

ESAMI PRE-OPERATORI INTERNI

Referto N. 6: Radiografia (RX) del Torace in 2 proiezioni

- **Data Esame:** 20/10/2025 (Eseguito 7 giorni pre-ricovero)
- **Sede:** Servizio di Radiologia, Ospedale "Lothlórien"
- **Medico Refertante:** Dott. Bilbo Baggins
- **Quesito Diagnostico:** Valutazione pre-operatoria. Enfisema noto.
- **Tecnica:** RX Torace 2 proiezioni (PA, LL), ortostatismo.
- **Reperto descrittivo:**
 - **Campi polmonari:**
 - Trasparenza: **Diffusa iperdiafania** bilaterale, più marcata agli apici (compatibile con **enfisema polmonare** noto).
 - Trama: Lieve accentuazione trama broncovascolare alle basi, rarefazione vascolare agli apici.
 - **Non addensamenti parenchimali focali** (non polmoniti, non masse).
 - **Ili polmonari:** Nei limiti, non linfadenomegalie.
 - **Mediastino:**
 - **Ombra cardiovascolare: Dimensioni nei limiti della norma** (Rapporto cardio-toracico <0.50). Non cardiomegalia.
 - Arco aortico lievemente prominente (età-correlato).
 - **Diaframma:**
 - Morfologia: **Lievemente appiattiti** (segno di iperinflazione cronica da enfisema).
 - Posizione: Lievemente abbassati.
 - **Seni costofrenici: LIBERI** (non versamento pleurico).
 - **Proiezione LL:**
 - Conferma iperinflazione: **Aumento del diametro antero-posteriore, aumento spazio aereo retrosternale.**
- **Conclusioni:**
 1. **Quadro radiologico compatibile con enfisema polmonare lieve-moderato, noto,** con segni di iperinflazione cronica. Stabile.
 2. **Non processi infettivi acuti in atto** (non polmoniti).
 3. **Seni costofrenici liberi** (non versamento pleurico).
 4. **Ombra cardiovascolare nei limiti.**
 5. **Giudizio Clinico:** Quadro stabile. **Non controindicazioni** all'intervento chirurgico.

(Firma Digitale: Dott. Bilbo Baggins)

VALUTAZIONI PRE-OPERATORIE SPECIALISTICHE

Valutazione Anestesiologica Pre-Operatoria

- **Data:** 27/10/2025 ore 16:00
- **Anestesista:** Dott.ssa Galadriel Noldor
- **Anamnesi Anestesiologica:**
 - Dati: 70 anni, 62 kg, BMI 22.0.
 - Patologie: Ipercolesterolemia, Carotidopatia 30% sn (Clopidogrel sospeso 5 gg), Enfisema lieve (SpO2 97% aa), Piastrinosi reattiva lieve.
 - **Allergie: Acido Acetilsalicilico (ASA - Aspirina) → Reazione orticarioide severa.** NEGA allergie a Lattice, Paracetamolo, Antibiotici, Anestetici locali.
 - Terapia: Rosuvastatina (prosegue), Clopidogrel (SOSPESO 5 gg).
 - **Anestesi pregresse: NESSUNA.**
 - Storia familiare anestesiologica: Negativa (per Ipertermia Maligna, ecc.).
 - Rischio PONV (Nausea/Vomito post-op): MODERATO (sesso F, non fumatrice). Profilassi indicata.
- **Esame Obiettivo Anestesiologico:**
 - Parametri vitali: PA 130/75, FC 70, SpO2 97%.
 - **Valutazione vie aeree (per eventuale emergenza):**
 - **Classificazione di Mallampati: Classe II** (visibili palato molle, ugola).
 - **Apertura bocca:** > 4 cm (Normale).
 - **Distanza Tiroo-Mentoniera (TMD):** > 6.5 cm (Normale).
 - **Mobilità collo:** Completa.
 - **Dentatura:** Protesi parziale superiore mobile (da rimuovere).
 - **Conclusione:** Basso rischio di intubazione difficile.
 - **Valutazione per Anestesia Spinale:**
 - **Esame rachide lombare:** Spazi intervertebrali L3-L4 e L4-L5 ben identificabili. Scoliosi lieve non controindicazione.
 - **Controindicazioni: NESSUNA.**
 - Coagulopatia: NO (INR 1.02, PLT 410k > 100k).
 - **Clopidogrel: SOSPESO da 5 giorni (tempo adeguato).**
 - **Rischio ematoma spinale: BASSO.**
 - Infezione: NO. Rifiuto paziente: NO.
- **Classificazione ASA (American Society of Anesthesiologists):**
 - **ASA 2** (Paziente con patologia sistemica lieve-moderata, controllata: ipercolesterolemia, carotidopatia 30% asintomatica, enfisema lieve).
 - **Rischio anestesiologico: BASSO-MODERATO.**
- **Piano Anestesiologico Proposto:**
 - **Tecnica: ANESTESIA SPINALE (SUBARACNOIDEA) + SEDAZIONE COSCIENTE**
 - **Razionale:** Evita intubazione (vantaggio per enfisema), miglior controllo dolore

post-op, minor PONV. Paziente cosciente o lievemente sedata.

- **Discussione e Consenso:** Paziente informata su alternative (Anestesia Generale) e rischi (ipotensione, cefalea PDPH, ritenzione urinaria, ematoma spinale [rarissimo, rischio basso], blocco alto [raro], danno neurologico [estremamente raro]). **Paziente esprime netta preferenza per anestesia spinale.** Acconsente.

- **Tecnica Dettagliata:**

1. **Anestesia Spinale:**

- Sede: L3-L4, posizione seduta.
- Asepsi rigorosa.
- Ago: **Whitacre 25G** (pencil-point, riduce rischio PDPH).
- Tecnica: Approccio mediano, conferma fuoriuscita liquor.
- Farmaco: **Bupivacaina 0.5% iperbarica (Heavy) 10 mg (2 ml)**. (Dosaggio basso-moderato, iperbarico per blocco "basso").
- Posizionamento: Supina (post-iniezione).
- Target: Blocco sensitivo fino a T10.

2. **Sedazione Cosciente:**

- Farmaco: **Propofol in TCI (Target-Controlled Infusion)**.
- Target: Ce 0.8-1.2 mcg/ml (sedazione lieve, paziente rilassata, respiro spontaneo).

3. **Monitoraggio Intra-Operatorio (Standard ASA):**

- ECG continuo, PANI (ogni 3-5 min), SpO2, FR.
- Ossigeno 2-3 L/min in cannule nasali.
- . Gestione Eventi:
 - **Ipotensione:** (Comune) Trattamento: Cristalloidi EV (precarico 500ml + bolo), **Efedrina 5-10 mg EV** al bisogno.
 - **Bradycardia:** (Possibile) Trattamento: Atropina 0.5 mg EV.
 - **Nausea:** Profilassi: Ondansetron 4 mg EV (a fine intervento).

4. **Profilassi Antibiotica:**

- **Cefazolina 2 grammi EV**, entro 30-60 min prima dell'incisione (ore 08:15).

5. **Profilassi Trombo-Embolica (TEV):**

- Rischio TEV: MODERATO (età >60, ortopedia, immobilizzazione).
- Profilassi:
 - Meccanica: **Calze elastiche anti-trombo** + Mobilizzazione precoce.
 - Farmacologica: **Enoxaparina (Clexane®) 4000 UI (40 mg) sottocute, 1 volta al dì, per 10 giorni.**
 - **Inizio EBPM: 1° giornata post-operatoria (sera)** (almeno 6-12h post-intervento).

6. **Gestione Clopidogrel:**

- **Ripresa: 1° giornata post-operatoria (sera 28/10)**, se non sanguinamento attivo (previa conferma chirurgo).

7. **Piano Post-Operatorio:**

- Destinazione: Recovery Room (1-2 ore), poi Reparto (se Aldrete ≥ 9).
- Terapia antalgica: Paracetamolo 1g EV/8h, Ketorolac 30mg EV/8-12h (max 2-3gg), Oppioidi (Tramadolo) solo al bisogno.
- Alimentazione: Liquidi dopo risoluzione blocco (4-6h post-op), se tollerati.
- Mobilizzazione: A letto fino a risoluzione blocco. Prima mobilizzazione con assistenza.

- **Conclusione Valutazione Anestesiologica:**

- Paziente **idonea**.
- **ASA 2**. Rischio Basso-Moderato.
- Tecnica: **Anestesia Spinale + Sedazione Cosciente**.
- **Nulla osta anestesiologico** all'intervento.
- Consenso informato sottoscritto.

(Firma e Timbro: Dott.ssa Galadriel Noldor, Data: 27/10/2025 ore 16:45)